

SEMINAR FOR SEITAI PRACTITIONERS

運動学から考える 整体施術の原理原則

— トレーニングの3原理・5原則を臨床に翻訳する —

90 min / 整体師向け / 新人～中堅

なぜ整体師に運動学が必要か

—触れる前に、見て・読むための共通言語—



再現性

経験則ではなく
原理から組み立てる施術



説明性

クライアントに
根拠ある説明ができる



波及性

施術後の指導まで
一貫した設計が可能

3原理・5原則とは

運動生理学・スポーツ科学の基本枠組み。施術と再教育の設計図として用いる。

3 原理

身体が変化する仕組み

1 過負荷の原理

2 可逆性の原理

3 特異性の原理

5 原則

介入を組み立てるルール

1. 全面性の原則

2. 漸進性の原則

3. 反復性の原則

4. 個別性の原則

5. 意識性の原則

PART 1

3原理

身体が変化する仕組みを理解する

01 過負荷の原理

DEFINITION

日常生活以上の負荷を加えなければ、身体に適応・変化は起きない。

整体現場への翻訳

- 「いつも通りの刺激」では身体は変わらない。慣れた負荷は適応の対象外
- 施術の刺激量・方向・速度を意図的に「日常を超える」設計にする
- お客様の日常動作の閾値を把握しないと、過負荷は設計できない

02 可逆性の原理

DEFINITION

獲得した適応は、刺激を止めると徐々に元に戻る。

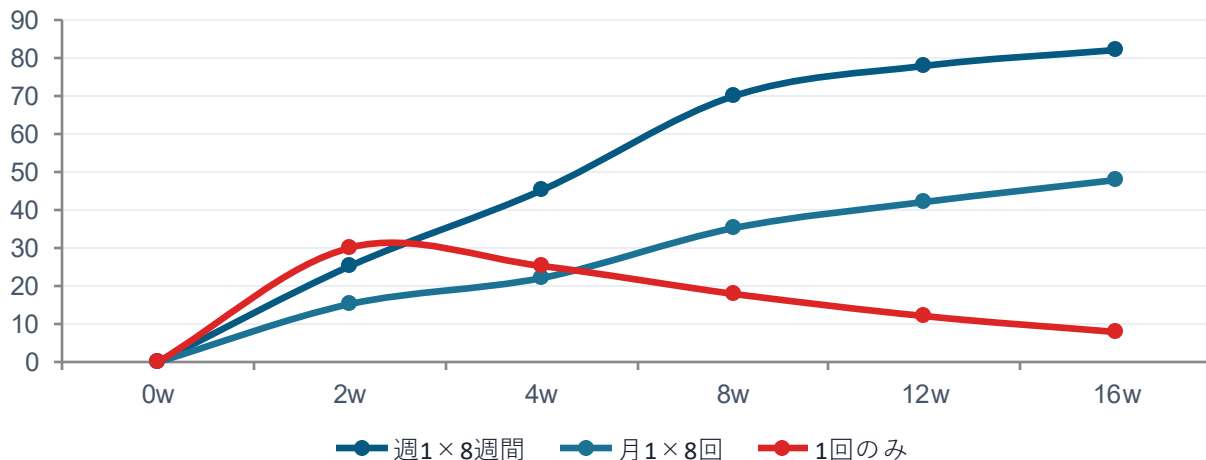
整体现場への翻訳

- 1回の施術で得た変化は「一時的」。戻る力(=日常動作)が常に働いている
- 戻る速度 = 獲得にかけた時間に比例。短期で出した変化は短期で消える
- 施術の効果を保つ条件は「次の刺激が入るまでの間隔」をどう設計するか

可逆性の原理－効果はなぜ戻るのか

施術頻度の違いによる「変化の保持率」モデル

適応の蓄積 (相対値)



頻度が低いと
獲得より戻るのが勝る

回数券の根拠は
ここにある

継続的な刺激の
設計こそが根本改善

注: 数値は概念モデルであり、効果量は症状・年齢・生活習慣により変動する。

03 特異性の原理

DEFINITION

身体は与えられた刺激の「種類・方向・速度」に特異的に適応する。

整体現場への翻訳

- 「腰痛だから腰を緩める」は特異性の誤用。解決したい動作と刺激が一致していない
- 歩行で痛むなら、歩行に近い肢位・速度・連鎖で刺激を入れる
- 再発予防は「日常動作と同じパターン」で身体に学習させることで成立する

特異性の原理－何を見て、何に合わせるか

肢位 (Position)

立位 / 座位 / 仰臥位 / 腹臥位
どの姿勢で痛むのか

方向 (Direction)

屈曲 / 伸展 / 回旋
どの方向で再現するか

速度 (Velocity)

ゆっくり / 素早く
速度依存の症状か

連鎖 (Chain)

閉鎖性 / 開放性
荷重あり/なしか

PART 2

5原則

介入を組み立てるための運用ルール

01 / 全面性の原則

一部分のみ強化・改善するのではなく、全身のバランスを取りながら整える。

運動学的根拠

筋連鎖

身体は連続した筋膜・関節連鎖で機能する。
患部だけ整えても上下流に歪みが残る。

対側性・拮抗筋(きっこうきん)の関係

一方が短縮すれば他方が弛緩する。両側を見ないと再発する。

現場での使い方

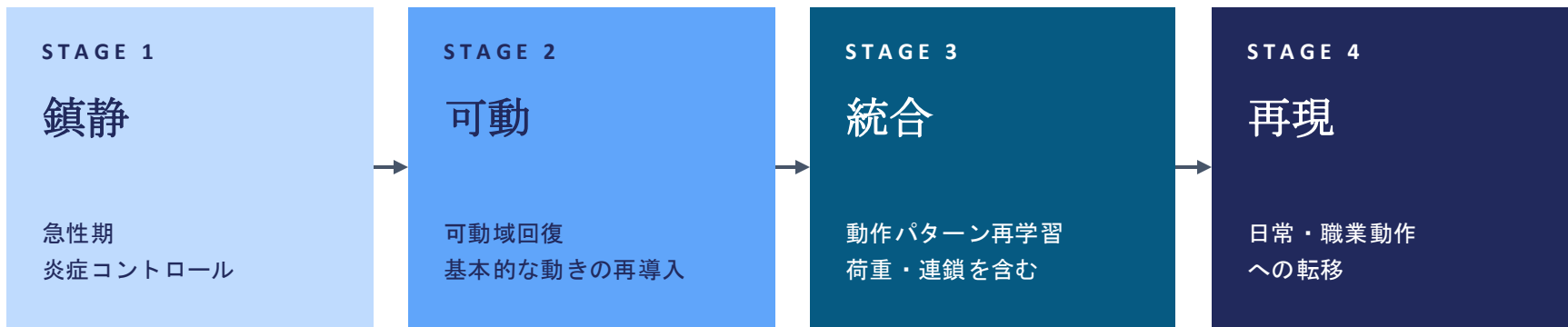
腰痛 → 腰だけでなく胸椎・股関節・足部まで評価
頸部症状 → 頸椎単独でなく肩甲帯・胸郭・呼吸まで

施術 + セルフケアでも、患部以外への入力を必ず1つは入れる

臨床ポイント: 患部は「結果」、原因は連鎖の上流または下流にある場合が多い

02 / 漸進性の原則

負荷・強度・難易度は、一気にではなく段階的に高めることで安全に適応する。



臨床ポイント: 「飛ばさない」 — 段階を確認するチェックポイントを必ず設ける

03 / 反復性の原則

身体の変化は単発では起きない。一定の頻度・期間の反復で初めて固定される。

神経学的根拠

シナプス可塑性

繰り返された動作パターンが神経回路として強化される。

運動学習の3段階

認知期 → 連合期 → 自動化期

反復なくして自動化はない。

現場での使い方

セルフケアは「数より頻度」

1日30回×1セットより、5回×6回/日が効く

施術の通院間隔を症状段階で設計

急性期は短く、安定期に向けて間隔を空ける

臨床ポイント: 「やる気」より「習慣化の仕組み」－生活動作に紐づけたケア指導を

04 / 個別性の原則

年齢・体力・生活背景・目標が異なる以上、最適な刺激量・方法も個別に異なる。

評価すべき個別因子

年齢・性別

組織の回復力
ホルモン環境

体力レベル

運動習慣の有無
基礎代謝

職業・姿勢

デスクワーク
立ち仕事 / 重労働

既往歴

過去の手術・外傷
慢性疾患

目標

痛み軽減 / 競技復帰
日常生活動作の自立 / 美容

心理状態

痛みへの恐怖
セルフケア継続性

臨床ポイント: 「同じ症状名 = 同じ施術」は誤り。問診で個別因子を必ず拾う

05 / 意識性の原則

意味・目的・部位を理解した動作は、無自覚な動作より圧倒的に効果が高い。

神経学的根拠

運動の活性化

意識を向けた筋肉への神経入力は、
無意識時より強く・選択的になる。

内的注意 vs 外的注意

症状改善には「身体内部への注意」が学習を促進する。

現場での使い方

施術中も「今どこに刺激が入っているか」を伝える
セルフケア指導は「なぜそれをするのか」と
セットで伝えると良い。

症状の改善経過を可視化し、自己効力感を上げる。

臨床ポイント: クライアントは「受け身の患者」ではなく「学習する主体」

本日のまとめ

3原理

身体が変化する仕組みの「物理法則」 — 過負荷・可逆性・特異性

5原則

介入を組み立てる「運用ルール」 — 全面性・漸進性・反復性・個別性・意識性

現場応用

原理原則が「観察・施術・指導」のすべての判断基準になる

整体は「経験則」ではなく「原理原則の翻訳」である。

PART 3

ケース統合

3原理・5原則で症例を読み解く

ケース 1 / 慢性腰痛

CLIENT

40代男性 / デスクワーク10年 / 朝の起床時に腰部こわばり / 週末は運動なし

特異性

座位での腰椎屈曲が長時間 → 伸展方向への刺激が抜けている

全面性

腰だけでなく胸椎伸展・股関節屈曲・呼吸まで評価

漸進性

急性期は炎症対応、可動回復後に荷重課題へ段階的移行

反復性

1日3回×短時間のセルフモビライゼーションを設計

個別性

デスクワーク中にできる動作 (椅子上でできる範囲) に合わせる

ケース 2 / 反復する寝違い

CLIENT

30代女性 / スマホ作業中心 / 半年に1度寝違い / 頭部前方位姿勢が顕著

過負荷

頸椎には常時負荷あり、施術は「日常を超える」可動入力を意図的に

可逆性

施術直後のアライメント変化は数日で戻る前提で頻度設計

特異性

睡眠時の頸椎肢位を再現して刺激方向を決定

全面性

頸椎単独でなく胸郭・肩甲帯・呼吸機能まで含めて評価

意識性

日中のスマホ姿勢に対する自己モニタリング能力を育てる